

Kunstiteraapia annab lapsele võimaluse väljendada end turvalisel viisil



Marika Ratnik

visuaalkunstiteraapia lektor, Tallinna Ülikool; kunsti- ja pereterapeut

Visuaalkunstiteraapia on üks loovteraapia alaliike kõrvuti muusika, tantsu- ja liikumis- ning draama-teraapiaga. Kõige sagedamini rakendatakse lastele ja noortele suunatud kunstiteraapiat sotsiaalses rehabilitatsioonis, kuid kunstiterapeute kaasatakse järjest enam ka haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste teenuseid osutavatesse meeskondadesse.

Artiklis on kasutatud visuaalkunstiteraapia asemel üldmõistet kunstiteraapia. Oma olemuselt on see psühhoterapeutiline ravi ja taastusravi (Rüütel 2017) ning tugineb kujutava kunsti eri tehnikate ja vahendite loomisele tõendus põhiste terapeutiliste sekkumismeetoditega. Kunstiteraapia põhineb kolmiksuhtel: klient, terapeut ja kliendi kunstilooming. Viimane toimib Bat-Ori ja Garti (2019) järgi kliendi mõtete ja tunnete kogujana ning info vahendajana ehk nähtavaks muutjana ja suhtluse toetajana. Terapeut on seejuures kliendi turvaline ja empaatiline saatja.

Kunst kui loominguine eneseväljendus

Kunstiteraapias on integreeritud loomingu põhine ja sõnaline eneseväljendus. Viimase osatähtsus oleneb teraapia eesmärgist, kliendi vanusest ja suutlikkusest eneseväljenduseks. Kui teraapias osaleb laps või nooruk, kel kõne puudub, saab tegevuse üles ehitada ainult

loominguilisele eneseväljendusele. See on üks kunstiteraapia eeliseid võrreldes verbaalsete lähenemistega. Kunstiline eneseväljendus on lapsele loomuo mane eneseväljenduse viis. Märkide ja sümbolite abil, olgu selleks siis tugeva pliiatsijoonega tehtud siksakid, mis võivad näida teravate hammastena, või suur, rõõmsate silmadega kollane päike, edastavad lapsed oma kogemusi olulistest suhetest, tegevustest, huvidest, väärtustest ning seni kogutud ja kogetud teadmistest.

Mida väiksem laps, seda mängulisem on teraapiaprotsess. Mõttelises ruumis, terapeudi ja lapse vahel, kus valmib lapse kunstilooming, saab toimuda sensomotoorne, sümboliline või lapse poolt juhendatud mäng (Piaget 1962). Kunstiterapeut Liebmanni (1986) järgi aitavad mäng ja mängulisus kaasa, et luua lapsega temast lähtuv turvaline abistamissuhe. Samuti võimaldab mäng lapsel kasutada reaalse elu probleemide ja uskumuste väljendamiseks verbaalset eneseväljendust toetavaid või asendavaid sümboleid.

Üldiselt ei ole loodu esteetiline väärtus kunstiteraapias oluline. Lapse ja noore jaoks võib olla loominguliselt nauditav ning mänguline värviliste käejälgede tegemine või saviga plätserdamine koos selle erinevate olekute (märg/kuiv) uurimisega, ilma et ta jõuaks „valmis” tulemuseni. Kuid alati tuleb arvesse võtta, et mõne lapse jaoks on loominguline kunstiline väärtus tähtis. Siis on terapeut abistajaks tehniliste võtete omandamisel ja loomingulise tegevuse planeerimisel, et laps saavutaks soovitud tulemuse ja kogeks eduelamust (Kramer 1986).

Kunstiteraapias „kõnelevad” terapeudi jaoks lapse loomingulise käitumise jälgimine, kunstitöö vormilised küljed ja lapse reageeringud ning mõtted oma tööst rääkimisel. Nii muutub nähtavaks lapse:

- üldine vaimse arengu tase, mille kohta annavad teavet joonistuse sellised ealised iseärasused nagu pildi ülesehitus, sisu, vormid, värvid, kujundid ja nende detailid ning pildi ideestik
- kognitiivne areng, mille kohta annavad teavet lapse keskendumisvõime, mälu ja mõtlemisprotsessid ning võime oma tegutsemist kontrollida
- emotsionaalne areng ehk lapse suutlikkus iseseisvalt või terapeudi abiga oma tundeid korrastada, väljendada ja nimetada
- sotsiaalsed oskused, mis väljenduvad lapse ja tema kunstitöö ning lapse ja terapeudi vastastikuses suhtes ja suhtluses
- motoorika areng, mis väljendub kunstivahendite ja erinevate materjalide käsitlemise suutlikkuses ja pildi vormilistes aspektides
- lapse suhtumine iseendasse ja talle olulistesse inimestesse ning igapäevaelu sündmuste tajumine.

Kunstiteraapias on võimalik kasutada mitmeid klientidega töötamise vorme: individuaal-, grupp-, paaristöö (laps ja terapeut või laps-laps paar).

Ameerika 20. sajandi kunstnik Andy Warhol, kes põdes lapsena neuroloogilist liikumishäiret, jõudis kunstini seeläbi, et tema ema veendumuse kohaselt aitab loominguline tegevus lapsel haigusega toime tulla ja väike Andy ümbritseti kunstivahenditega (fotokaamera, värvimisraamatud, ajakirjad, kunstiraamatud). Warholi enda arvates mõjutas see tema hilisemat kujunemist kunstnikuks.

Sekkumistasandid töös laste ja noorukitega

Loovterapeut ja Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate professor Eha Rüütel (2017) on kirjeldanud viit mittehierarhilist loovteraapia sekkumistasandit, mis eristavad kunstiteraapia eesmärke ja tööviise.

Psühhoterapeutilisel tasandil rakendatakse erinevaid verbaalseid ehk sõnalisi (peegeldamine, restruktureerimine jne) ning mängulisi (rollimängud, lugude loomine ja illustreerimine, kujutlusmatkad, kangelase-meetod) terapeutilisi tehnikaid, et aidata lapsel muuta nähtavaks ja mõtestada tema muresid ja/või traumaatilisi kogemusi, mis võivad olla seotud pereliikmete, sõprade või koolisuhetega. Psühhoterapeutilisel tasandil tugevuste ja ressursside ning käitumisstrateegiatega analüüsimisest on abi, kui laps tunneb, et ta ei suuda vastata temale oluliste täiskasvanute ootustele ja see muudab ta ebakindlaks ning tõrjuvaks. Siinkohal näide 14aastasest tütarlapsest, kelle suunas kunstiteraapiasse lastekaitsetöötaja, et toetada neiu emotsionaalset heaolu, mida mõjutas lahutanud vanemate vaenulikkus üksteise suhtes: valdavalt juhendatud (terapeut pakkus teema) kunstitööd aitasid neil väljendada oma mõtteid ja tundeid seoses vanemate pingeliste suhetega, kuid ka algkoolis

kogetud kiusamisega, millest ta seni ei olnud rääkinud. Tema hea kunstitehnikate tundmine toetas rahulolu valminud kunstitöödega, mis omakorda toetas tema enesekindlust ja isiklikest tugevustest teadlikumaks saamist.

Funktsionaalses kunstiteraapias tegeldakse erinevate funktsioonide toetamise ja oskuste arendamisega kunstipõhiste meetodite ja tehnikate abil. Näiteks laiendatakse autistlike joontega lapse loomingulise (julgus kasutada erinevaid kunstimaterjale, -vahendeid, -tehnikaid) ja sõnalise eneseväljenduse (julgus esitada küsimusi, kirjeldada kunstitööd) repertuaari. Keskendumisraskustega lastele on abi struktureeritud loomingulisest keskkonnast ja ülesannetest. Kunstiprojekti elluviimine jaotatakse väikesteks visualiseeritud sammudeks, mis toetavad last idee juures püsimisel ja edenemise märkamisel. Näiteks viis Ayaszi (2018) oma uurimuses läbi 6,5aastase mõõduka intellektipuude ning aktiivsuse- ja tähelepanuhäire diagnoosiga (ATH) tüdrukuga 25seansilise käitumusliku kunstiteraapia, mille tulemusena vähenesid tüdruku ATH sümptomid.

Kunstiterapeut on vajaduse korral koostööpartner ka lapsevanemale või õpetajale, jagades soovitusi, kuidas toetada lapse eri funktsioonide või sotsiaalsete oskuste arendamist – nii lisandub kunstiteraapiasse vanemat või õpetajat hariv ja juhendav aspekt. Näiteks võimaldas teadlik vanem kergete autistlike joontega lapsel osaleda koos sõbraga kunstiteraapias kogu õppeaasta jooksul. Üle nädala toimunud seansside eesmärk oli analüüsida laste koolisuhteid ning arendada nende koostööoskust, üksteise kuulamis- ja abistamisoskust. Selles protsessis olid alati lapsed kunstivahendite, -tehnikate ja teemade pakkujad. Terapeudi ülesanne oli üles ehitada seansside struktuur, mis toetaks eesmärkide saavutamist. Koostöös terapeudiga toimus nimetatud oskuste arendamine ka kodus.

Rekreatiivses ehk üldist toimetulekut taastavas ja toetavas kunstiteraapias on ühendatud heaolutunde toetamine ja loovuse virgutamine. Kunstiteraapia heaolu toetavat potentsiaali on otstarbekas kasutada haiglaravil viibivate lastega, kes seisavad silmitsi mitme psühholoogilise väljakutsega: võõras keskkond, vabaduse piiramine, usalduskriis vanemate ja laste vahel, ebamugavad protseduurid. Kunstiterapeut Rubin (2005) on öelnud, et kunst on haiglas viibivale lapsele kui „hea ravim” ja Councilli (2012) järgi toetab see laste enesehinnangut, autonoomiat ning sisendab lootust. Näiteks on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit koostöös Eesti Loovteraapiate Ühingu kunstiterapeutidega võimaldanud kunstiteraapiat vähihaigetele lastele. Björling jt (2019) kasutasid aga oma uuringus hinnanguvaba hetkele keskendumise ehk teadveloleku tehnikatega integreeritud 20minutilisi kunstiteraapilisi tegevusi 14–18aastastele peavalu all kannatavatele tütarlastele. See oli osa eklektilisest teraapiast, mida viisid ellu kunstiterapeutid. Tüdrukud väitsid, et kunstiteraapilised tegevused olid rahustavad; samuti väärtustati terapeutide hinnanguvaba suhtumist.

Sageli lõimitakse kunstiteraapias eri sekku mistasandeid. Näiteks pakuti koolis **rekreatiiv-funktsionaalset grupikunstiteraapiat**, mida rahastas kohalik omavalitsus ning mille eesmärk oli I ja II klassi õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine koolisuhete toetamiseks. Kooli meeskonda mitte kuulunud kunstiterapeudi koostööpartnerid olid kooli tugispetsialistid. Väikestes rühmades (3–4 last) toimunud iganädalased kunstiteraapia seansid kavandati kindlate oskuste arendamiseks. Terapeut tegi loomingulise protsessi vaatlemisele tuginedes ka märkmeid laste tugevuste ja arendamist vajavate käitumuslike või isiksuslike asjaolude kohta, mida jagas konfidentsiaalsuse reegleid jälgides teiste tugispetsialistidega.

Palliatiivne kunstiteraapia pakub lohutust ja leevendust siis, kui lapse või nooruki elutee hakkab raske või kroonilise kuluga haiguse tagajärjel lõppema. Nii näiteks kirjeldavad Councill ja Ramsey (2019) oma artiklis 18 kuu pikkust palliatiivse kunstiteraapia tegevusi, milles osalesid 4aastane vähihaige poiss ja tema pereliikmed. Poisil oli ninaneelu kasvaja, mida ei õnnestunud ravida. Kunstiteraapia eesmärk oli pakkuda nii lapsele kui ka tema pereliikmetele psühhosotsiaalset toetust alates haiguse ilmsiks tulekust kuni lapse surmani.

Diagnostiline tasand on oma olemuselt kunstiteraapiline hindamine, et selgitada välja lapse tugevusi, arengupotentsiaali, stressiallikaid ja toimetuleku strateegiaid. Kogutud info toetab koos lapse ja vanematega või hoopis koos kohaliku omavalitsuse spetsialistidega kavandatava teraapiaprotsessi eesmärgistamist ning selle tulemuslikkuse hindamist. Kunstiterapeudid kasutavad selleks enamasti erisuguseid juhendatud joonistusi koos küsimustike ja testidega, mille kasutamiseks neil on luba ning väljaõpe. Juhendatud loominguliste tegevuste abil on võimalik uurida lapse minapilti (inimese joonistamine), aga ka seda, kuidas ta tajub ennast peres (perepilt, kus pereliikmed on oma tavalistes tegevustes; perekonna skulptuur, mille loomiseks kasutatakse näiteks savist voolitavaid pereliikmete kujusid) või koolis (pilt koolipäevast). Välja saab selgitada ka lapse toimetulekuressursse (joonistus inimesest, kes võtab õunapuult õuna) või hinnata tema koostööoskust (paaristöö terapeudiga). Näiteks võib tuua ühe väga andeka ja analüüsiva 11aastase poisi hindamise protsessi, kelle vanematel oli raske mõista, miks tema koolisuhted eakaaslaste ja õpetajatega on keerulised. Paaristöö kunstiterapias näitas, et tal oli raske aktsepteerida teise osalise (sel juhul terapeudi) ideid ühise kunstitöö puhul; samuti kippusid tema ideed tegutsemise käigus kiirelt muutuma nii, et algne projekt sai uue

sisu; loomingulist protsessi saatsid pidevad mitteteemakohased küsimused ja kui terapeut neile kohe vastuseid ei leidnud, andis noormees mõista, et tema on siiski targem. Kunstiteraapia käigus ilmnenu lapse tugevuste ja/või eripära selgitamine koos tema tööde vaatlemisega (vorm ja sisu) aitas vanematel kooli muret paremini mõista. Kunstitööde kasutamine vanematele tagasiside andmiseks oli lapsega kooskõlastatud, sest lapselt peab alati küsima luba, et kunstitööd vanematega jagada ja/või pildistada.

Teraapia mitmekülgsed võimalused

Selles artiklis on esitatud ülevaade kunstiteraapia mitmekesistest võimalustest, tuginedes sekkumistasanditele. Eraldi tutvustamist vääriks ka perekonna kunstiteraapia ja vanemlaps diaadi kunstiteraapia, mille abil saab hinnata vanema ja lapse suhet ning kavandada teraapilisi sekkumisi selle tugevdamiseks. Kunstiterapiast võib abi olla ka arengulise trauma (hooletusse jätmine, väärkohtlemine) või üheksordse traumakogemuse korral, mis on omaette teema.

Loodu esteetiline väärtus ei ole kunstiterapias oluline.

Kunstiterapiat terapeutilise sekkumisena võiksid lastekaitsetöötajad kaaluda, kui tegu on koolieelses või nooremas koolieas lapsega, kel võivad olla ka hariduslikud erivajadused. Näiteks võimaldas üks omavalitsus kümneansilise kunstiteraapia seitsmeaastasele kooliteed alustavale lapsele, et toetada tema julgust ja enesekindlust eneseväljendamisel. Lapse loomingulise tegutsemise jälgimine ja kunstitööde abil vestlemine näitas, et laps vajab kooliteed alustades tuge ka õppimisel

ja suhete loomisel ning lapsevanem sai selleks tagasiside ja soovitusel.

Kunstiteraapia võib kujundilise ja sümbolilise keele tõttu olla turvaline seksu-mismeetod ka väärtkoheldud/hooletusse jäetud või traumakogemusega lastele (sh ka vanemate lahtutuse või koolikiusamise korral). Kuid graafiline ja kujundiline eneseväljendus võib pakkuda huvi ka ekspressiivsetele ja

mässulistele teismelistele.

Grupikunstiteraapia sobib ka näiteks puudega laste vanematele, et pakkuda neile emotsionaalset tuge ja turvalist keskkonda personaalsete ning perekondlike ressursside uurimiseks. Võimalusi on teisigi: miks mitte luua kunstiteraapia rühmad lastekaitsetöötajatele endile tööpinge leevendamiseks ja loovuse ning huumori virgutamiseks. **S**

Juba üle kümne aasta on Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate eriala, kus üheks spetsialiseerumise suunaks on visuaalkunstiteraapia. Loe lähemalt www.tlu.ee/kunstiteraapiad.

Juhendatud joonistamist võiks kasutada kogemusega spetsialist, kes teab, kuidas kasutada joonistamist turvaliselt ning mis mõtteid või tundeid võib üks või teine juhend tekitada. Kunstiteraapiate eriala juures toimuvad igal aastal täienduskoolitused, kuhu on oodatud ka lastekaitsetöötajad; peale selle korraldatakse just lastekaitsetöötajatele mõeldud koolitusi, mille fookus on juhendatud joonistuste kasutamisel lastekaitsetöös. Infot koolituste kohta saab e-posti aadressil kadri.herde@tlu.ee.

Viidatud allikad

- Ayaz, H. (2018). Art as Therapy with a Child with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder – Comorbid Intellectual Disability: A Case Study. *Journal of Basic & Applied Sciences*, 14, 156–160.
- Bat-Or, M., Garti, D. (2019). Art therapist's perceptions of the role of the art medium in the treatment of bereaved clients in art therapy. *Death Studies*, 43(3), 193–203. DOI: 10.1080/07481187.2018.1445138.
- Björling, E., A., Stevens, C., Singh, N., B. (2019). Participatory Pilot of an Art-Based Mindfulness Intervention for Adolescent Girls With Headache, *Art Therapy*, DOI: 10.1080/07421656.2019.1609325.
- Councill, D. A. (2012). Medical art therapy with children. Teoses: Malchiodi, C. (toim.) *Handbook of art therapy*. New York, NY: Guilford Press, 222–240.
- Councill, D. A., Ramsey, K. (2019). Art Therapy as a Psychosocial Support in a Child's Palliative Care. *Journal of American Art Therapy Association*, 36, (1) 40–44.
- Kramer, E. (1986). The art therapist's third hand: Reflections on art, art therapy, and society at large. *American Journal of Art Therapy*, 24, 71–86.
- Liebmann, M. (1986). *Art Therapy for Groups: A Handbook of Themes, Games and Exercises*. Routledge.
- Piaget, J. (1962). *Play, dreams, and imitation in childhood*. New York: Norton.
- Rubin, J. A. (2005). *Child art therapy* (25th edition). New Jersey: John Wiley & Sons.
- Rüütel, E. (2017). Loovteraapia kontseptsioonist, rakendamisest ja tõendus põhiseusest. *Eesti Arst*, 96 (11), 661–668.